

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065030-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA DO CARMO CAMPOS

MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "RITUXIMABE 500MG, NA POSOLOGIA DE 375MG/M2, NO TOTAL DE 6 (SEIS) DOSES, COM DOSE CALCULADA POR CICLO DE 580MG/CICLO". IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A TAL RECURSO. PARECER DO NAT DE ACORDO COM O FORNECIMENTO.. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5065030-82.2024.4.02.5101

510014459183 .V8

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065030-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA DO CARMO CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, na qual a União, objetiva atribuir efeito suspensivo a decisão proferida nos autos originários de nº **50074731320244025110** (Evento 36) pelo juízo do Juízo Substituto do 5º VF de Niterói que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado, com vistas ao fornecimento do medicamento "*Rituximabe 500mg, na posologia de 375mg/M2, no total de 6 (seis) doses, com dose calculada por ciclo de 580mg/ciclo, conforme prescrição médica*".

A parte autora apresentou contrarrazões (evento 14).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União em face da decisão proferida no evento 36 doas autos originários (processo 5007473-13.2024.4.02.5110/RJ, evento 36, DESPADEC1):

"Cuida-se de ação proposta por Maria do Carmo Campos em face da União Federal, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São João de Meriti, objetivando o fornecimento de Rituximabe 500mg, na posologia de 375mg/M2, no total de 6 (seis) doses, com dose calculada por ciclo de 580mg/ciclo, conforme prescrição médica.

deu termo a determinação de intimação do Núcleo de Assistência Técnica - NAT para que apresentasse parecer.

Intimado a se manifestar sobre o caso, o Ministério Público Federal tomou ciência e renunciou ao prazo (Eventos 22 e 24).

O Núcleo de Assistência Técnica - NAT apresentou parecer (Evento 34).

É o relatório. Decido.

No caso, conforme a documentação médica juntada aos autos, verifica-se que a autora é portadora de Linfoma Não Hodgkin de Células do Manto (CID10: C83.8) e afirma ter realizado tratamento quimioterápico convencional à base de Ciclosfamida, Vincristina, Doxorrubicina e Prednisona, sem melhora, necessitando, por isso, de associação com o medicamento Rituximabe ao CHOP ante o risco de piora do quadro clínico.

Conforme consta do Parecer do NAT (evento 34), o referido medicamento encontra-se validamente registrado na ANVISA, padronizado no SUS e está previsto em bula para tratamento de linfoma não-Hodgkin. Contudo, quanto à doença da demandante (C83.8 - Outros tipos de linfoma não-Hodgkin difuso), não está prevista entre as contempladas para a retirada do medicamento pela via do CEAF.

Logo, o caso narrado remete ao uso off-label do medicamento, ou seja, o medicamento pleiteado ainda não foi autorizado por agência reguladora (ANVISA) para tratar especificamente a enfermidade da parte autora. Contudo, o próprio parecer técnico indica que, em grande parte das vezes, o uso se mostra essencialmente correto, embora ainda não aprovado pelas autoridades.

Assim sendo, o caso narrado diferencia-se da hipótese elencada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 106 (Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 21/09/2018) que versa sobre a concessão, pela via judicial, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, se preenchidos os seguintes requisitos cumulativos:

"i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

O fornecimento do medicamento Rituximabe para tratamento da mesma enfermidade da autora (Linfoma Não Hodgkin de Células do Manto (CID10: C83.8) vem sendo disponibilizado judicialmente para pacientes que o possuem, bem como para outras enfermidades, ante a existência de estudos científicos que apontam a melhora da condição dos pacientes em uso off label, conforme verificado na decisão monocrática abaixo referida sobre caso semelhante:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERMITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"(AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento."

STJ, AgInt no AREsp n. 1.964.268/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023. Julgamento por Unanimidade.

A Coordenadoria de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti informou que o Rituximabe está na grade de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, porém não está incluído para tratamento da hipótese diagnóstica indicada em laudo (Evento 1/OFIC7).

Em casos análogos, assim decidiu o TRF da 2ª Região:

"CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - SAÚDE - TEMA 793 STF, SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - AFASTADA TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - TEMA 106 DO EG.

STJ. TEMA 500 DO EG. STF - REGISTRO NA ANVISA DO MEDICAMENTO PARA OUTRA ENFERMIDADE - AUTORA HIPOSSUFICIENTE - SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 421 DO EG. STJ I - Autora, 56 anos, com diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico que desenvolveu lesões cutâneas de outra doença autoimune, Pênfigo Foliáceo, fechando diagnóstico de Pênfigo Eritematoso (que é o pênfigo foliáceo em paciente com Lupus). É refratária a todos os esquemas de tratamento disponíveis (Aziotropina, micofenolato de profetil, prednisona, hidroxicloroquina). II - O Eg. STF, em sede de repercussão geral, fixou o Tema 793, publicado no DJE de 03/06/2019, como segue: ("Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde..."). III - O Eg. STF tem precedentes no sentido de que o judiciário ao conceder direito a medicamentos deve verificar o caso concreto a ser analisado, e, a presente hipótese trata de enfermidade que causa "lesão cutânea crônica por toda a superfície da pele, que possui caráter desfigurante, acometendo a face e o tronco" e, quanto à urgência do medicamento, considera-se a evolução da doença afirmada em laudo expedido por médico de órgão público de que "a paciente piorou das lesões, agora com manifestação da doença no rosto todo, o que torna difícil suas atividades laborativas". IV - Também tem entendimento nas Cortes Superiores de que a atuação do Judiciário, quando determina fornecimento de medicamento, deve se pautar na omissão da administração pública, o que ocorre na presente hipótese, cujos esquemas de tratamentos disponíveis não apresentam mais opções para a Autora. V - O medicamento ora requerido - Rituximabe 500 mg - encontra-se incluído nas listas oficiais de dispensação pelo SUS (embora não para o mal que acomete a Autora), sendo certo, portanto, que não se trata de medicamento cujo "alto" custo afastaria o fornecimento gratuito pelos órgãos públicos. VI - O Eg. STJ julgou o RESP 1.657.156 - RJ, firmando a seguinte TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015: "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência." O item "i" restou comprovados por diversos laudos emitidos por médicos de hospitais públicos vinculados ao SUS, bem como pelo parecer do NAT, órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O item "ii" também foi confirmado nos autos. VII - Quanto ao registro na ANVISA, sinala-se que o medicamento requerido - Rituximabe 500 mg - é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para outra doença. O mesmo medicamento foi deferido, em julgado do Eg. STJ contemporâneo ao julgamento do RESP 1.657.156-RJ, para enfermidade não constante em bula aprovada pela ANVISA, e em julgado anterior do Eg. STF. VIII - O Eg. STF no Tema 500, cujo acórdão não foi publicado até o presente, prevê que "1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais" e, que "2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial". Havendo registro na ANVISA para o medicamento ora requerido, embora para outra doença, não há óbice no presente deferimento. IX - O Tema 793 do Eg. STF determina que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.". Assim, determina-se que o ônus da aquisição do medicamento recaia sobre a União Federal, na qualidade de gestora do SUS. Sinala-se que, nos termos do art. 516, II, do NCPC, o juízo competente para o cumprimento da sentença é o que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, logo cabe ao MM. Juízo a quo direcionar o efetivo cumprimento do decisor. X - Sendo da União Federal a responsabilidade pelo ressarcimento financeiro da aquisição do medicamento somente sobre ela deve recair a condenação em honorários de sucumbência, a qual, contudo, deixa-se de aplicar em face do instituto da confusão, por estar a parte Autora representada pela Defensoria Pública Federal, nos termos do no Enunciado nº 421 do STJ. XI - Apesar de a Súmula nº 421 do Eg. STJ ter sido editada em 2010, e os precedentes que a originaram serem anteriores a vigência da Lei Complementar nº 132/2009 e das Emendas Constitucionais nº 69/2012, 74/2013 e 80/2014, é certo que se encontra ainda atual a citada jurisprudência. Nesse sentido, tanto o julgamento do Eg. STJ em efeito repetitivo, como julgados recentes mantiveram a mesma tese. XII - Apelação cível provida."

TRF2, AC 0062428-87.2016.4.02.5101, 7ª Turma Especializada, Relator Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer, Julgamento em 25/11/2020.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE (MABTHERA®). DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR NILZA SILVA INACIO, REPRESENTADA POR MARCIA SILVA INÁCIO VICTORINO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, OBJETIVANDO QUE LHE FOSSE FORNECIDO O MEDICAMENTO "RITUXIMABE (MABTHERA®)". 2. O ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ASSEVERA QUE A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, COMPETINDO, NA FORMA DO ART. 197, PRIMORDIALMENTE AO PODER PÚBLICO, A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS QUE GARANTAM AO CIDADÃO, EM ÚLTIMA ANÁLISE, O SEU DIREITO À VIDA. 3. SENDO O DIREITO À SAÚDE UM BEM CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO, NÃO É POSSÍVEL QUE A NORMA PROGRAMÁTICA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO SEJA INTERPRETADA DE MODO A TORNAR-SE UMA "PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE", POIS ALÉM DE QUALIFICAR-SE COMO DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE A TODAS AS PESSOAS, REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA, INTRINSECAMENTE LIGADO, AINDA, AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, QUE É A RAZÃO, O CENTRO GRAVITACIONAL DO SISTEMA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL EM VIGOR. 4. NO CASO EM COMENTO, A AGRAVANTE DEMONSTROU DOCUMENTALMENTE QUE É PORTADORA DE LINFOMA NÃO-HODGKINS DE PEQUENAS CÉLULAS (CID 10 C83.0), COM VOLUMOSA ESPLENOMEGALIA COMPATÍVEL COM LINFOMA DA ZONA MARGINAL ESPLÊNICO, NECESSITANDO DO MEDICAMENTO

RITUXIMABE (MABTHERA), NA DOSE DE 375 MG/MQ POR CICLO, EM UM TOTAL DE 6 CICLOS, PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO SUBSCRITO PELA DRA. KATIA PETRUCCIO URAGO TURON, CRM 52667099, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (FLS. 18/24, DO ANEXO 2, DO EVENTO 1º GRAU). APONTA A MÉDICA QUE O TRATAMENTO É FUNDAMENTAL, VISTO QUE A AGRAVANTE JÁ FOI SUBMETIDA A 6 CICLOS DE POLIQUIMIOTERAPIA, MAS NÃO SURTIU O EFEITO NECESSÁRIO, COM REMISSÃO APENAS PARCIAL DA DOENÇA. O LAUDO ESCLARECE QUE O RITUXIMABE É INDICADO EM TODOS OS LINFOMAS QUE EXPRESSAM A MOLÉCULA CD 20, SENDO UMA INDICAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO E INDICADO JÁ NA PRIMEIRA LINHA DE TRATAMENTO, E QUE A AGRAVANTE CORRE RISCO DE MORTE, SENDO CERTO QUE O MEDICAMENTO PLEITEADO POSSUI INDICAÇÃO EM BULA PARA O TRATAMENTO E QUE O MEDICAMENTO PLEITEADO É FORNECIDO PELO SUS, MAS NÃO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA QUE A ACOMETE. ADEMAIS, A PACIENTE TEM 73 ANOS E PORTADORA DA DOENÇA ALZHEIMER, DIFICULTANDO MAIS O TRATAMENTO.5. COM EFEITO, O PARECER DO NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES DE SAÚDE - NAT, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, INFORMA QUE O MEDICAMENTO RITUXIMABE OU MABTHERA POSSUI INDICAÇÃO CLÍNICA NÃO PREVISTA EM BULA PARA O TRATAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA AGRAVANTE. INFORMOU, AINDA, QUE O MESMO NÃO INTEGRA LISTA OFICIAL DE MEDICAMENTOS, PARA DISPENSAÇÃO NO SUS, E DEVEM SER FORNECIDOS DIRETAMENTE PELAS UNACONS OU CACONS, RESPONSÁVEIS PELO TRATAMENTO DO CÂNCER COMO UM TODO E QUE A UNIDADE DE SAÚDE ONDE A AUTORA, ORA AGRAVANTE, ESTÁ SENDO ASSISTIDA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO) ESTÁ HABILITADA COMO CACON. CABE DESTACAR QUE O MEDICAMENTO ESTÁ DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA, SOB O NÚMERO DE REGISTRO 101000548.6. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO JULGAR O EDCL NO RESP Nº 1.657.156 FIXOU A TESE PARA A CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS, EXIGINDO-SE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS SEGUINTE REQUISITOS: I) COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS; II) INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; III) EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA, OBSERVADOS OS USOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA.7. ATENDIDOS NA HIPÓTESE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO, ESTABELECIDOS NO JULGADO ACIMA INDICADO (EDCL NO RESP Nº 1.657.156), RESTANDO PATENTE A PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. O PERICULUM IN MORA MOSTRA-SE, TAMBÉM, EVIDENTE EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA RECORRENTE.8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, para que os agravados forneçam a medicação RITUXIMABE (MabThera ®), conforme prescrito no anexo 2, do evento 1/1º grau, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado."

TRF2, 5ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento, 5010880-02.2022.4.02.0000, Rel. Desembargador Federal ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO, Rel. do Acórdão - Desembargador Federal ALCIDES MARTINS, julgado em 08/03/2023, julgamento por Unanimidade.

Diante do exposto, na forma da fundamentação supra, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com fulcro no art. 4º, da Lei nº 10.259/01 c/c art. 300, do Código de Processo Civil, para determinar que os réus, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam à parte autora o medicamento Rituximabe 500mg, nos termos da prescrição médica constante dos autos.

Considerando o parecer do NAT, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), onde a paciente recebe acompanhamento médico e recebeu a medicação ora pleiteada (cf. Evento 01/OFFIC7), também deverá ser intimado para diligenciar o cumprimento da decisão.

Intime-se, através do Sr. Oficial de Justiça, o diretor do Hospital Universitário Fraga Filho (HUCFF) para fins de ciência e cumprimento desta decisão, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente.

Intimem-se as rés para ciência e cumprimento desta decisão.

Intime-se a parte autora para ciência desta decisão, por meio da Defensoria Pública da União em São João de Meriti.

Citem-se os réus para apresentarem respostas (art. 335 do CPC) no prazo legal e trazerem aos autos toda a documentação de que disponham para o esclarecimento da causa, bem como especificarem justificadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC).

Com a resposta, venham os autos conclusos."

Requeru efeito suspensivo e o seu inteiro provimento para a cassação da antecipação dos efeitos da tutela.

É o breve relatório.

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva e à solidariedade dos entes públicos federativos, verbis:

“Processo REsp 1203244 / SC RECURSO ESPECIAL 2010/0137528-8

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO

Data do Julgamento 09/04/2014

Data da Publicação/Fonte DJe 17/06/2014 RIP vol. 87 p. 283

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTOS**. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de **medicamentos** ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios”, e “o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional”, razão por que “o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida” (RE

607.381 AgR. Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA Seção do Superior Tribunal de Justiça: “A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Ari Pargendler e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentaram, oralmente, os Drs. SÉRGIO LAGUNA PEREIRA, pelo recorrente, e DANIELLE ALEIXO REIS DO VALLE SOUZA, pela União.

Notas

Julgado conforme procedimento previsto para os **Recursos Repetitivos** no âmbito do STJ. Veja os **EDcl no REsp 1203244-SC** que foram acolhidos.”

Assim, os cidadãos podem postular a concessão de medicamentos, insumos e, por analogia, procedimentos médicos de todos os órgãos federados.

Pois bem, sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, a parte autora comprovou todos os requisitos.

A parte autora comprovou ser portadora de linfoma não- Hodgkin da zona do manto CD20 positivo.

O NAT juntou parecer (processo 5007473-13.2024.4.02.5110/RJ, evento 34, PARECER1).

III – CONCLUSÃO

1. Informa-se que o medicamento **Rituximabe** está indicado em bula⁵ para o manejo de **linfoma não-Hodgkin** - quadro clínico apresentado pela Autora, conforme relato médico.

2. No que tange à disponibilização do medicamento pleiteado no âmbito do SUS, insta mencionar que **Rituximabe 500mg é disponibilizado** pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)⁶, aos pacientes que se enquadrem nos critérios de inclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Artrite Reumatoide, e conforme o disposto na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e na Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelecem as normas de financiamento e de execução do CEAF no âmbito do SUS.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

➤ **Rituximabe 500mg** é disponibilizado pelo CEAF perfazendo o grupo de financiamento 1A do referido componente: *medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estado e Distrito Federal*^{6,7}.

3. Os medicamentos do CEAF somente serão autorizados e disponibilizados para as doenças descritas na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) contempladas. Assim, a doença do demandante, a saber C83.8 – Outros tipos de linfoma não-Hodgkin difuso não está dentre as contempladas para a retirada do medicamento pela via do CEAF, impossibilitando a obtenção do Rituximabe de forma administrativa.

4. O medicamento **Rituximabe possui registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), contudo até o momento não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC⁸) para o tratamento de **linfoma não-Hodgkin de células do manto**.

5. Considerando o caso em tela, informa-se que no momento não há publicado pelo Ministério da Saúde Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)⁹ para o manejo de **linfoma não-Hodgkin de células do manto** e **Outros tipos de linfoma não-Hodgkin difuso** (CID-10: C83.3), e, portanto, não há lista oficial e específica de medicamentos que possam ser implementados nestas circunstâncias.

6. Como a Autora apresenta uma neoplasia (linfoma não Hodgkin de células do manto), informa-se que, no que tange à disponibilização de medicamentos oncológicos, o acesso aos medicamentos dos pacientes portadores de câncer no âmbito do SUS, destaca-se que não existe uma lista oficial e específica de medicamentos antineoplásicos para dispensação, uma vez que o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde não fornecem medicamentos contra o câncer de forma direta (por meio de programas).

7. Para atender de forma integral e integrada aos pacientes portadores das neoplasias malignas (câncer), o Ministério da Saúde estruturou-se através de unidades de saúde referência UNACONS e CACONS, sendo estas as responsáveis pelo tratamento como um todo, incluindo a seleção e o fornecimento de medicamentos antineoplásicos e ainda daqueles utilizados em concomitância à quimioterapia, para o tratamento de náuseas, vômitos, dor, proteção do trato digestivo e outros indicados para o manejo de eventuais complicações.

8. Elucida-se que o fornecimento dos medicamentos oncológicos ocorre por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial (Apac-SIA) do SUS, devendo ser oferecidos pelos hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia, sendo ressarcidos pelo Ministério da Saúde conforme o código do procedimento registrado na Apac. A

tabela de procedimentos do SUS não refere medicamentos oncológicos, mas situações tumorais específicas que são descritas independentemente de qual esquema terapêutico seja adotado¹⁰.

9. Assim, os estabelecimentos habilitados em Oncologia pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento do câncer que, padronizam, adquirem e prescrevem, devendo observar protocolos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, quando existentes.

10. Nesse sentido, é importante registrar que as unidades de saúde do SUS habilitados em Oncologia são responsáveis pelo tratamento integral do paciente, logo, não representam meros pontos de distribuição de antineoplásicos ou terapia adjuvante.

11. Convém informar que, no documento médico acostado aos autos (Evento 1_OFIC 1, págs. 1 a 3), não foi possível identificar em qual unidade de saúde a Autora está sendo assistida. Deste modo, caso a Autora esteja sendo assistida em unidade de saúde habilitada em oncologia e vinculada ao SUS - Rede de Atenção em Oncologia (Anexo I), é de responsabilidade da referida unidade garantir a Autora o atendimento integral preconizado pelo SUS para o tratamento de sua condição clínica, incluindo o fornecimento dos medicamentos necessários.

12. Caso não seja assistida em unidade de saúde habilitada em oncologia, para que tenha acesso ao atendimento integral e seja integrada na Rede de Atenção em Oncologia (Anexo I), deverá ser inserida no fluxo de acesso, conforme a nova Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer e em consonância com a Política Nacional de Regulação, ingressando via Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

13. Em relação ao questionamento sobre *a doença da qual padece a parte autora é grave*, destaca-se que de acordo com literatura consultada, os **linfomas de células do manto (LCM)** são neoplasias linfoides usualmente disseminadas ao diagnóstico, que representam aproximadamente 6% dos linfomas não-Hodgkin (LNHs). São incuráveis e de comportamento agressivo, com sobrevida média de três a cinco anos. Os pacientes são, comumente, masculinos, com idade mediana de 60 anos, apresentando sintomatologia B, linfadenomegalia generalizada, esplenomegalia e infiltração da medula óssea. Pode haver envolvimento do trato gastrointestinal com múltiplos pólipos linfomatosos¹¹.

14. Sobre se *há risco de morte caso não seja iniciado tratamento imediato*. Entende-se que cabe ao médico assistente uma avaliação mais precisa acerca dos riscos inerentes à condição clínica atual da Autora. No relato médico (Evento 1_OFIC 1, pág. 2), consta que *“...A não realização do tratamento ocasionará a paciente risco de morte, perda irreversível de órgão ou de função”*.

15. Quanto aos *laudos médicos anexados à inicial estão de acordo com as alegações formuladas pela autora ou há alguma incongruência entre eles*. Informa-se que sim estão de acordo com as alegações formuladas pela autora.

16. É possível determinar o *preço médio da unidade ou caixa do medicamento pleiteado e quantas unidades ou caixas o requerente necessitará para o tratamento?* No que tange ao preço médio – vide item 19 desta Conclusão. Quanto a quantidade o requerente necessitará para o tratamento – segundo relato médico (Evento 1_OFIC 1, pág. 2), Autora deverá fazer uso de *“...Rituximabe 580mg/ciclo, no total de 6 ciclos...”*.

17. No que concerne ao valor do medicamento pleiteado, no Brasil para um medicamento ser comercializado no país é preciso obter o registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a autorização de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)¹².

18. De acordo com publicação da CMED¹³, o **Preço Fábrica (PF)** deve ser utilizado como referência quando a aquisição dos medicamentos não for determinada por ordem judicial e os medicamentos não se encontrarem relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, que regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3 de 2011, e o **Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)** é utilizado como referência quando a compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013.

19. Assim, considerando a regulamentação vigente, m consulta a Tabela de Preços CMED, o Bio-Manguinhos **Rituximabe 10mg/mL** frasco 50mL possui preço de fábrica R\$ 11.882,16, e o preço máximo de venda ao governo R\$ 9.323,93, para o ICMS 20%¹³.

É o parecer.

O parecer afirmou que o medicamento pleiteado está indicado em bula para o manejo de linfoma não-Hodgkin - quadro clínico apresentado pela Autora, é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), mas que a patologia apresentada não está dentre as contempladas para a retirada do medicamento pela via do CEEF, impossibilitando a obtenção do Rituximabe de forma administrativa. Afirmou que o Rituximabe possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Quanto a alegação de que os medicamentos não devem ser fornecidos porque não estão padronizados pela rede pública e/ou adequados aos protocolos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, tal argumentação não merece respaldo.

No julgamento do recurso especial em questão, firmou-se a tese, em caráter repetitivo, de que, medicamentos que tenham sido aprovados pela ANVISA, mas que, não tenham ainda sido incluídos na lista oficial de dispensação, podem ser concedidos gratuitamente pelo SUS, eis que, há um direito subjetivo do cidadão contra o Estado, também quanto a eles.

Acerca do tema, vide o Tema 106 dos representativos do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“Processo REsp 1657156 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0025629-7

Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142)

Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO

Data do Julgamento 25/04/2018

Data da Publicação/Fonte DJe 04/05/2018

Ementa

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.**

*1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de **medicamentos** (colírios: azorga 5 ml, glauk 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos **medicamentos**. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de **medicamentos** prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de **medicamentos** constantes em listas editadas pelos entes públicos.*

*Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer **medicamentos** não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.*

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 *A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.*

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Assusete Magalhães (voto-vista) e os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Notas

Julgado conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito do STJ."

Sabe-se que a tutela da saúde, estampada especificamente a partir do art. 196 da CF/88, deve ser perseguida não apenas pelo indivíduo, mas também pelo Estado (lato sensu), como corolário da dignidade da pessoa humana, fundamento de nossa ordem constitucional, prevista especificamente no art. 3º, III da CF/88.

Quanto à hipossuficiência, a parte autora está representada pela defensoria pública, sendo esta presumida.

Ainda, no que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

*Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispôs: "**ENUNCIADO 40** - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."*

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que o tratamento médico seja fornecido à parte autora.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

O Tema 793, estabeleceu que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178, em 23.05.2019).

Na mesma direção, os enunciados 8, 60, 87 CNJ trataram, respectivamente, do respeito à repartição de competências entre os entes, da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes e da individualização da atribuição dos entes.

Assim, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No caso, o NAT afirmou que o medicamento é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), mas que o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), é onde a paciente recebe acompanhamento médico e recebeu a medicação ora pleiteada. Assim correta a determinação judicial para determinar que os réus forneçam à parte autora o medicamento Rituximabe 500mg.

Logo, é possível afirmar que os requisitos para a concessão estavam presentes, tanto no que se refere à verossimilhança das alegações, quanto ao risco de lesão grave e/ou de difícil reparação.

*Por essas razões, **indefiro o requerimento de natureza cautelar de atribuição de efeito suspensivo**. Intimem-se.*

Após, à conclusão para voto."

Logo, a decisão concessiva atacada observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais e não há algum *periculum in mora* inverso ou argumento relacionado a questões de ordem pública relevante, que autorize a concessão da pretendida suspensão da decisão.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.

